L'IPM calculé sur l'EHCVM 2021 au service du PND 2026-2030

Analyse d'alignement

Pipeline `PythonIPM`

Septembre 2026

Résumé

Ce document confronte l'indice de pauvreté multidimensionnelle calculé sur l'EHCVM 2021 au Plan National de Développement 2026-2030. Il ne juge ni le plan ni l'indice : il établit, cible par cible, ce que l'un permet de mesurer de l'autre, ce qu'il ne permet pas, et l'usage auquel il se prête le mieux dans le dispositif de suivi du PND. Un document jumeau traite de l'IPM calculé sur le RGPH 2021 ; un troisième les compare et conclut.

La conclusion en cinq lignes

- L'avantage de l'EHCVM sur le recensement tient à **trois indicateurs**, et deux d'entre eux sont des indicateurs de santé : l'assurance maladie, le renoncement aux soins, et l'année de scolarité mesurée exactement plutôt qu'approchée par le diplôme.
- Il est **le seul** à donner prise aux cibles santé et nutrition du Pilier 4 — Couverture Maladie Universelle, protection sociale, accès effectif aux soins — auxquelles le recensement n'en donne aucune, faute de tout module de santé.
- Il est **le seul** à porter la pauvreté monétaire et la pauvreté multidimensionnelle dans la même base, ce dont l'objectif « baisser significativement le taux de pauvreté » a besoin.
- Étant une **enquête répétée**, il peut être recalculé en cours de plan, là où le recensement, décennal, ne le pourra pas.
- Il ne sert en revanche **pas le ciblage territorial** du Pilier 5 : la moitié de la population vit dans une sous-préfecture dont l'IPM n'est pas publiable.

Table des matières

1 Ce que le PND demande à un indice de pauvreté **2**

2 La correspondance, cible par cible **2**
2.1 Pilier 4 — Capital humain, compétences et emplois décents 3
2.2 Pilier 5 — Infrastructures, pôles régionaux et transition écologique 3
2.3 Piliers 2, 3 et 6 4

3 Les quatre apports que l'EHCVM est seul à fournir **4**
3.1 La Couverture Maladie Universelle et la protection sociale 4
3.2 La sécurité nutritionnelle 4
3.3 L'accès effectif aux soins 4
3.4 Le genre et la pauvreté monétaire 5

4 Ce que l'IPM EHCVM ne peut pas faire pour le PND 6
4.1 Le ciblage territorial du Pilier 5 6
4.2 Les cibles hors champ 6

5 L'usage auquel l'IPM EHCVM se prête 7
5.1 Le tableau de bord du cadre de résultats 7
5.2 Le suivi dans le temps 7

6 Limites de cette analyse 7

1 Ce que le PND demande à un indice de pauvreté

Le PND 2026-2030 vise à « Bâtir une Grande Nation Stable, Ambitieuse et Solidaire ». Parmi ses objectifs généraux figure de **« baisser significativement le taux de pauvreté »** — et c'est le seul des objectifs majeurs qui ne soit assorti d'aucune valeur cible à 2030, là où le revenu intermédiaire supérieur, les trois millions d'emplois décents, l'Indice de Capital Humain à 0,7 et les IDE à 3,3 % du PIB le sont tous.

Une cible manquante, et l'occasion qu'elle ouvre

Le PND documente la trajectoire de la pauvreté monétaire — 55,4 % en 2011, 44,4 % en 2015, 39,4 % en 2018, 37,5 % en 2021 — mais ne fixe pas de valeur à atteindre en 2030. Un indice de pauvreté multidimensionnelle est précisément l'instrument qui permettrait de la poser, et de la suivre sur une grandeur qui ne dépend pas des seuls prix.

Le plan formule par ailleurs, pilier par pilier, des cibles chiffrées assorties d'une valeur de départ et d'une valeur 2030. Ce sont elles qui donnent la mesure de l'alignement : un indice est utile au PND dans l'exacte mesure où ses indicateurs recoupent ces cibles.

2 La correspondance, cible par cible

Les seize indicateurs de l'IPM EHCVM se rapportent aux cibles du PND comme suit. La colonne « Aujourd'hui » donne la part de la population vivant dans un ménage privé sur l'indicateur.

2.1 Pilier 4 — Capital humain, compétences et emplois décents

Cible PND à 2030	Indicateur IPM	Auj.	Prise
Analphabétisme adultes 51,1 → 45 %	Alphabétisation	62,9 %	directe
Analphabétisme 15-24 ans 37,6 → 20 %	Alphabétisation	62,9 %	directe
Achèvement 1er cycle secondaire 81,14 → 89 %	Année de scolarité	62,9 %	directe
Personnes à moins de 5 km d'un centre de santé 82 → 100 %	Renoncement aux soins, motif d'indisponibilité de l'offre	9,0 %	directe
Enrôlés à la CMU 20 → 30 millions	Assurance maladie	90,2 %	directe
Couverture par la protection sociale 27 → 50 %	Assurance maladie	90,2 %	directe
Chômage et main-d'œuvre potentielle (SU3) 12,9 → 8,9 %	Chômage	6,5 %	directe
Retard de croissance des moins de 5 ans 21,4 → 18 %	Insécurité alimentaire (FIES)	40,8 %	indirecte
Espérance de vie 62,3 → 65 ans	—	—	aucune
Indice de l'écart genre 0,655 → 0,7	désagrégation par sexe du chef de ménage	—	partielle
827 000 ménages bénéficiaires des filets sociaux	identification des ménages pauvres	—	partielle
Préscolaire 11 → 25 % ; EFTP 6,2 → 15 % ; IPS primaire	—	—	aucune

2.2 Pilier 5 — Infrastructures, pôles régionaux et transition écologique

Cible PND à 2030	Indicateur IPM	Auj.	Prise
Accès à une source d'eau améliorée 81 → 90 %	Eau potable	20,9 %	directe
Accès à l'assainissement amélioré 37 → 70 %	Toilette	67,2 %	directe
Accès universel à l'électricité d'ici 2030, en priorité dans les quartiers précaires	Électricité	9,3 %	directe
Habitat décent (défi n° 5 du diagnostic stratégique)	Logement, Promiscuité	17,3 % ; 12,5 %	directe
Population utilisant internet 40,7 → 60 %	Biens d'équipement	21,7 %	indirecte
Pôles économiques compétitifs, villes secondaires, réduction des inégalités régionales	désagrégation territoriale	—	faible

2.3 Piliers 2, 3 et 6

Cible ou orientation PND	Indicateur IPM	Auj.	Prise
Enregistrement des naissances 56,6 → 100 % (P. 6)	Déclaration d'état civil	26,3 %	directe
NNI 27,78 → 100 % (P. 6)	Déclaration d'état civil	26,3 %	indirecte
Modernisation de l'agriculture et productivité (P. 2) ; réduction de l'informalité (P. 3)	Emploi agricole de subsistance	40,5 %	directe
Énergie de cuisson propre (transition écologique, P. 5)	Énergie de cuisson	66,3 %	directe
Registre social unifié pour le ciblage (P. 6)	—	—	aucune

Le décompte, et ce qu'il ne dit pas

Sur les vingt-deux cibles et orientations du PND qu'un indice de pauvreté peut éclairer, l'IPM EHCVM en couvre **onze de façon directe**, trois de façon indirecte, deux partiellement, et laisse six hors de portée.
Ce décompte est à manier avec prudence : il compte des *cibles*, et plusieurs cibles retombent sur le *même* indicateur — les deux cibles d'analphabétisme comme les deux cibles de couverture sociale. En indicateurs distincts à prise directe, le compte tombe à **neuf**.
Il favorise en outre mécaniquement la source qui porte le plus d'indicateurs : l'EHCVM en a seize, le RGPH treize. Ce n'est pas un résultat, c'est une propriété du questionnaire.

3 Les quatre apports que l'EHCVM est seul à fournir

3.1 La Couverture Maladie Universelle et la protection sociale

Le PND fixe deux cibles chiffrées sur ce terrain : porter les enrôlés à la CMU de 20 à 30 millions, et la couverture par un dispositif de protection sociale de 27 à 50 %. L'indicateur `assurance_maladie` de l'IPM les mesure directement, à l'échelle du ménage.

Le chiffre qu'il donne est d'ailleurs le plus frappant de tout l'indice : **90,2 % de la population vit dans un ménage dont aucun membre n'est couvert**. C'est un ordre de grandeur que la cible CMU du PND — 30 millions d'enrôlés sur une population de 29,8 millions — laisse penser atteignable, à condition de distinguer l'enrôlement de la couverture effective.

3.2 La sécurité nutritionnelle

Le PND fait de la sécurité nutritionnelle un axe stratégique à part entière du Pilier 4, avec une cible sur le retard de croissance des moins de 5 ans (21,4 → 18 %) et une insistance sur les « 2 000 premiers jours de vie ».

L'EHCVM ne mesure pas l'anthropométrie, mais elle porte l'échelle FIES de la FAO, sur laquelle l'IPM construit son indicateur d'insécurité alimentaire : **40,8 % de la population vit dans un ménage en insécurité alimentaire modérée ou sévère**. Ce n'est pas le retard de croissance, mais c'est la mesure du déterminant immédiat que le PND cherche à traiter.

3.3 L'accès effectif aux soins

La cible « porter la proportion de personnes vivant à moins de 5 km d'un établissement de santé de 82 à 100 % » est une cible d'offre. L'indicateur `renoncement_soins` mesure le résultat de

cette offre du point de vue du ménage : un membre a eu un problème de santé, n'a pas consulté, et a cité comme raison le coût ou **l'indisponibilité du service ou du personnel**.

C'est ce second motif qui intéresse directement le PND : il mesure le déficit d'offre là où il est subi, et non la distance théorique à un établissement.

3.4 Le genre et la pauvreté monétaire

Le **sexe du chef de ménage** est disponible dans l'EHCVM et permet de désagréger l'indice par sexe — ce que le recensement, dans l'extrait transmis, ne permet pas.

Ne pas surestimer cet avantage

Deux réserves. D'abord, désagréger l'IPM par sexe du chef de ménage ne *mesure* pas la cible « indice de l'écart genre 0,655 → 0,7 » : cet indice est un composite couvrant l'emploi, l'éducation, la santé et la représentation politique. C'est un éclairage, pas une mesure.
Ensuite, l'absence du sexe au RGPH est un fait de **transmission, non de collecte** : la numérotation des questions de l'extrait passe de P16 à P18, la question P17 manquant — c'est très probablement le sexe. Une demande à l'INS lèverait cette limite du côté du recensement.

L'apport réellement propre à l'EHCVM est ailleurs : elle porte dans la même base la **consommation des ménages** : c'est elle qui produit le taux de pauvreté monétaire cité par le PND. Les deux pauvretés peuvent donc être croisées ménage par ménage.

Le tableau ci-dessous porte sur les 9 800 ménages pour lesquels l'indicateur de bien-être est renseigné, soit 18,7 millions de personnes.

	Pauvre au sens de l'IPM	**Non pauvre IPM**
Pauvre monétaire	41,7 %	6,7 %
Non pauvre monétaire	28,2 %	23,4 %

Deux enseignements, dont un seul est solide.

Le premier l'est : **86,1 % des pauvres monétaires sont aussi pauvres au sens multidimensionnel**. C'est un rapport calculé à l'intérieur du champ, donc insensible à la façon dont on traite les ménages sans indicateur de bien-être — il vaut 86,1 % quelle que soit la convention retenue. La pauvreté monétaire est presque entièrement incluse dans la pauvreté multidimensionnelle.

Le second ne l'est pas au même degré, mais sa direction ne fait pas de doute : une part importante de la population est **privée sans être pauvre monétairement** — 28,2 points ici, 31,7 points si l'on raisonne sur l'ensemble de l'échantillon. Une politique qui ne suivrait que le revenu manquerait cette population, que le PND entend pourtant servir.

Pourquoi les niveaux ne doivent pas être publiés tels quels

L'indicateur de bien-être (`pcexp`) et le seuil national (`zref`) ne sont renseignés que pour **9 800 ménages sur 12 965**, soit 75,6 % de l'échantillon et 62,9 % de la population pondérée : le module de consommation n'est pas exploitable pour un quart des ménages.
Aucune des deux lectures possibles ne retombe sur le chiffre publié :

Lecture	Taux monétaire
Manquants comptés non pauvres, sur toute la population	30,5 %
Champ restreint aux 9 800 ménages renseignés	48,5 %
Publié, et repris par le PND	**37,5 %**

Et le sous-champ n'est pas neutre : l'IPM y vaut 69,9 % contre 58,0 % sur l'échantillon complet. **Les ménages disposant d'un indicateur de bien-être sont plus pauvres que la moyenne.** Reproduire le 37,5 % demanderait la pondération ou l'imputation que l'INS applique à ce sous-champ, qui ne figurent pas dans la base.
Les déflateurs spatial et temporel présents dans la base (`def_spa`, `def_temp`) ne sont pas en cause : quelle que soit la façon de les appliquer, le taux reste entre 30,3 et 30,9 %.
À retenir : le taux de recouvrement de 86,1 % est publiable, les quatre cases du tableau ne le sont pas avant que la méthode officielle de calcul du taux monétaire ait été reprise.

4 Ce que l'IPM EHCVM ne peut pas faire pour le PND

4.1 Le ciblage territorial du Pilier 5

Le Pilier 5 repose sur une « planification spatiale des investissements, fondée sur une cartographie fine des potentialités économiques régionales », sur des Pôles Économiques Compétitifs et sur le développement des villes secondaires. Le Pilier 6 prévoit un « registre social unifié visant à renforcer l'inclusion et le ciblage des politiques publiques ». Le Pilier 4 fixe un objectif de 827 000 ménages bénéficiaires de transferts monétaires.

Ces trois orientations demandent une information à la maille du territoire et, pour la dernière, à la maille du ménage. L'EHCVM est un échantillon de 12 965 ménages : elle ne peut satisfaire ni l'une ni l'autre.

La moitié de la population hors de portée d'un chiffre publiable

Sur les 442 sous-préfectures et communes que l'EHCVM permet de distinguer, **92 — soit 47,9 % de la population** — ont un IPM dont le coefficient de variation dépasse 20 % : le chiffre existe, mais il n'est pas publiable.
À la maille du département, 15 des 108 sont dans ce cas, couvrant 7,1 % de la population.
Autrement dit : l'EHCVM donne un IPM solide pour le pays, pour les deux milieux et pour les 33 régions, mais elle ne peut pas fonder une allocation d'investissements à la maille où le Pilier 5 entend la conduire.

4.2 Les cibles hors champ

Six cibles du PND restent sans prise : l'espérance de vie, le taux net de scolarisation au préscolaire, la part de l'EFTP dans le secondaire, l'indice de parité filles/garçons dans le primaire, le NNI et le registre social unifié. Les quatre premières relèvent de statistiques sectorielles ; les deux dernières, d'un système d'information administratif.

5 L'usage auquel l'IPM EHCVM se prête

5.1 Le tableau de bord du cadre de résultats

C'est son emploi naturel. Onze cibles du PND, réparties sur quatre piliers, peuvent être suivies sur un indicateur unique, décomposable, dont la contribution de chaque dimension est explicite.

Dimension	**Poids nominal**	**Contribution à M_0**
Éducation	25 %	32,3 %
Santé	25 %	27,9 %
Conditions de vie	25 %	21,3 %
Emploi	25 %	18,5 %

Un gouvernement qui veut savoir quel levier déplacerait le plus l'indice dispose là de la réponse, et elle est directement transposable en priorités de pilier.

5.2 Le suivi dans le temps

Le PND court sur cinq ans et prévoit un cadre de gouvernance chargé d'en mesurer les progrès. Or l'EHCVM est une **enquête répétée** : elle existe pour 2018 et pour 2021.

Ce qui est établi, et ce qui ne l'est pas

Ce qui est certain : le RGPH est **décennal**, le prochain n'interviendra pas avant la fin du plan, et le recensement ne pourra donc mesurer aucun progrès du PND.
Ce qui ne l'est pas : le calendrier de la prochaine vague d'EHCVM. Le rythme passé (2018, puis 2021) le laisse attendre dans l'intervalle du plan, mais **aucune programmation n'a été vérifiée ici**. L'argument « l'EHCVM permettra le suivi » suppose cette vague ; il est à confirmer auprès de l'INS avant d'être avancé devant une instance de décision.

Trois emplois immédiats

1. **Poser la cible manquante.** L'objectif « baisser significativement le taux de pauvreté » peut être chiffré sur $M_0 = 0{,}2863$ (2021), avec une valeur 2030 explicite.
2. **Alimenter le cadre de résultats** sur les onze cibles à prise directe, en une seule série cohérente plutôt qu'en onze statistiques sectorielles.
3. **Arbitrer entre piliers** au vu des contributions : la dimension Santé pèse 28,4 % de l'indice, la dimension Emploi 18,2 %.

6 Limites de cette analyse

1. **Les correspondances ne sont pas des identités.** « Alphabétisation » au sens de l'IPM est un indicateur de ménage — un membre de 17-49 ans ne sait pas lire ou écrire le français — tandis que la cible PND porte sur un taux individuel. Les deux évoluent dans le même sens sans être le même nombre.
2. **La dimension Santé de l'IPM EHCVM est portée à 93,4 % des ménages par l'assurance maladie**, ce qui en fait un indicateur peu discriminant (voir la *Note sur la dimension santé*). Son poids dans l'indice doit être lu avec cette réserve.
3. **Le croisement monétaire / multidimensionnel ne reproduit pas le taux de pauvreté publié**, parce que l'indicateur de bien-être manque pour un quart des ménages et

que ce quart n'est pas tiré au hasard. Seul le taux de recouvrement entre les deux pauvretés (86,1 %) est robuste à ce défaut.

4. **Le décompte des cibles favorise la source la mieux dotée en indicateurs**, et compte plusieurs fois un même indicateur quand plusieurs cibles s'y rapportent. L'écart réel entre les deux sources porte sur trois indicateurs distincts, dont deux de santé.
5. **Le PND ne contient pas de cible d'IPM.** L'alignement établi ici est un alignement de *contenu*, pas une correspondance institutionnelle : il resterait à faire adopter l'indice dans le cadre de gouvernance du plan.